

PROCEDIMIENTO PARA AISLAMIENTO PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS

1. OBJETIVO.

Unificar criterios para la adecuada aplicación del protocolo sobre aislamiento inverso, con el fin de prevenir Infecciones Asociadas a la atención de Salud (IAAS).

2. ALCANCE.

Este proceso inicia cuando el médico tratante indica el ingreso y finaliza cuando el personal de salud ingresa a la habitación con la medida precautoria correspondiente (Inversa) y aplica las funciones asistenciales.

3. DEFINICIONES.

3.1 IAAS: Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), se definen de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), como aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital o Centro Sanitario, que no estaba presente, ni en período de incubación al momento de su ingreso y que pueden inclusive llegar a manifestarse después del alta del paciente.

3.2 **Medida precautoria inversa:** Medida diseñada para evitar el acceso de microorganismos en pacientes con alta vulnerabilidad a las infecciones y son para proteger pacientes severamente inmunodeprimidos y no infectados.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 **Actualización:** Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UEH).

4.2 **Ejecución:** Médico tratante, admisión, supervisión de enfermería, médico de guardia, enfermería, personal clínico/no clínico, laboratorio e intendencia, UEH.

4.3 **Supervisión:** Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UEH).

PROCEDIMIENTO PARA AISLAMIENTO PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS

5. DESARROLLO DEL PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	MÉDICO TRATANTE	Indica el ingreso del paciente, con su diagnóstico establecido.
5.2	ADMISIÓN	Realiza el trámite de ingreso administrativo y avisa a supervisión de enfermería. (PR-CS-01)
5.3	SUPERVISIÓN ENFERMERÍA	Revisa indicaciones y detecta paciente inmunodeprimido.
5.4		Determina habitación de aislamiento y medida precautoria a implementar (Inversa-Lila). (FT-UV-05) Nota: En caso de tener duda avisa al departamento de UVEH.
5.5		Realiza visita e identifica paciente con sospecha clínica o con diagnóstico certero de paciente inmunodeprimido y avisa al departamento de UVEH, Supervisión de enfermería y determina la medida precautoria a implementar. (FT-UV-05)
5.6		Notifica al médico tratante del aislamiento en caso de no conocerlo.
5.7	MÉDICO DE GUARDIA	Coloca en la habitación medida precautoria correspondiente al ingreso de la habitación (inversa). (IT-UV-14)
5.8		Nota: El tarjetón de colocarse en un lugar visible, esta será en la puerta de entrada y si el personal tiene alguna duda si se trata de un paciente inmunodeprimido o de que medida precautoria le corresponde, se puede basar en el formato FT-UV-05.
5.9		Realizar higiene de manos durante los 5 momentos (IT-UV-01) y (IT-UV-04)
5.10		Colocar adecuadamente el equipo de protección correspondiente:
	ENFERMERIA	• Usar bata de manga larga (IT-UV-05) • Colocación correcta del cubrebocas (IT-UV-06)
		Manejo adecuado de los Residuos Peligros Biológicos e Infecciosos, así como desecho adecuado de punzocortantes.

PROCEDIMIENTO PARA AISLAMIENTO PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS

5.11	TODO PERSONAL CLÍNICO Y NO CLÍNICO	Se deberá explicar al paciente y a sus familiares o visitantes la razón del aislamiento, así como la importancia de utilizar el equipo de protección, donde solicitarlo, ejemplo: cubre boca y bata.
5.12		Nota: el personal deberá explicar al familiar al familiar cómo se coloca el equipo de protección.
5.13		Los dispositivos médicos y biomédicos que está en contacto con el paciente deberán desinfectarse antes y después de usarse. (IT-JE-45)
5.14	LABORATORIO	Todo personal que requiera ingresar a la habitación deberá respetar las medidas precautorias establecidas.
5.16	UVEH	Informar inmediatamente al departamento de UVEH si detecta y/ aísla gérmenes multirresistentes en cultivos del paciente.
5.17	INTENDENCIA	Nota: si es el resultado del cultivo corresponde a una IAAS (caso nuevo) se avisa a los departamentos involucrados y se inicia el aislamiento infeccioso (PR-UV-11)
		Avisa a los supervisores de enfermería y médicos de guardia y modifica el tipo de aseo para habitación.
		En las habitaciones con paciente en aislamiento deberá realizarse el aseo rutinario y aseo "Exhaustivo" .

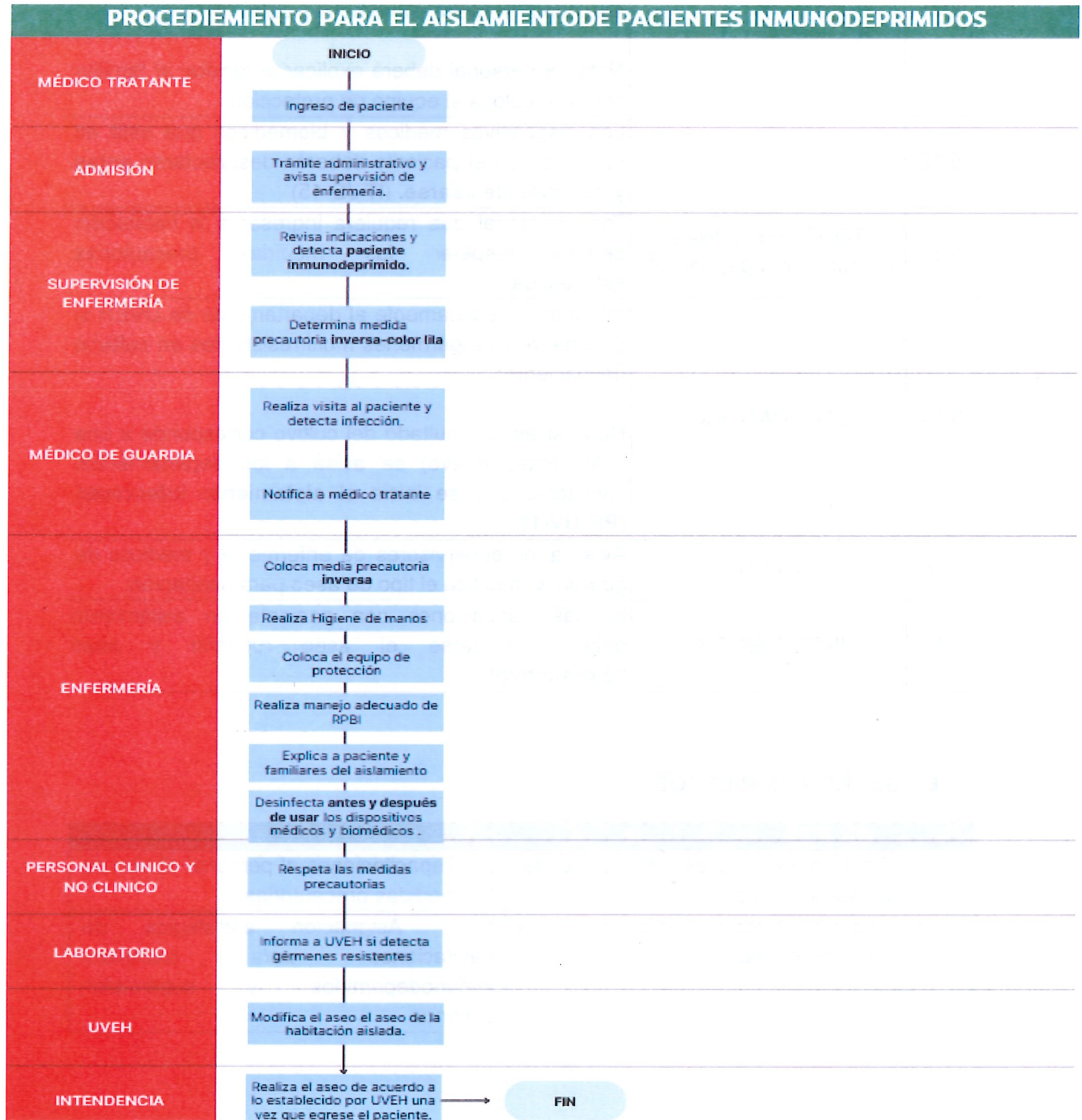
6. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Omisión del proceso por parte del personal clínico.	a. Capacitaciones al personal clínico de las medidas precautorias.
b. Adquirir Infección Asociada a la atención de salud.	b. Asignación estratégica de habitaciones para pacientes inmunodeprimidos y supervisión continua.

PROCEDIMIENTO PARA AISLAMIENTO PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS

7. ANEXOS.

7.1 Flujograma



PROCEDIMIENTO PARA AISLAMIENTO PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS

7.2 Documentos de referencia.

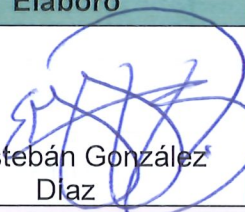
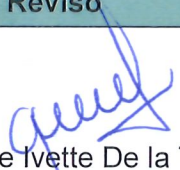
Nombre del documento	Código
Medidas precautorias	FT-UV-05
Precauciones inversa tarjeta lila	IT-UV-14
Instrucción de trabajo para la higiene de manos con agua y jabón.	IT-UV-01
Instrucción de trabajo para la higiene de manos con gel alcoholado.	IT-UV-04
Higiene de manos con gel alcoholado	IT-UV-04
Colocación correcta de bata	IT-UV-05
Colocación correcta del cubrebocas	IT-UV-06
Proceso para el abastecimiento de insumos para la higiene de manos	PR-UV-01
Desmontaje y sanitización de material	IT-JE-45
Limpieza y desinfección de habitaciones	IT-IN-01
Procedimiento para el ingreso de pacientes a hospitalización.	PR-CS-01
Guía De Aplicación De La Estrategia Multimodal De La OMS, Para La Mejora De La Higiene De Manos (2010).	NA
Norma Oficial Mexicana Nom-045-Ssa2-2015, Para La Vigilancia Epidemiológica, Prevención Y Control De Las Infecciones Nosocomiales.	NA

PROCEDIMIENTO PARA AISLAMIENTO PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS

8. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	03/06/2021	Alta de documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	08/09/2023	Modificación de documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
03	26/09/2025	Actualización de procedimiento	Lic. Viridiana López Fajardo	Dr. Estebán González Díaz

9. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Dr. Estebán González Díaz	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Dr. José Gonzalo Vázquez Camacho
Jefatura de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UEVH)	Jefatura de Calidad	Dirección Médica